



# Un manual de Sanidad combate el estigma en salud mental, la Terapia de Aceptación y Compromiso muestra beneficios en cuidados paliativos y se publica la convocatoria PIR 2026-2027 con 293 plazas de Psicología: claves del 11 de septiembre de 2026

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026

## Resumen rápido del día

---

El Ministerio de Sanidad y el Comisionado de Salud Mental presentan el Manual de reparación, una guía dirigida a la población general para acompañar a personas con problemas de salud mental y combatir el estigma. Una revisión sistemática con metaanálisis publicada en Psicothema concluye que la Terapia de Aceptación y Compromiso puede mejorar la calidad de vida y reducir la ansiedad y la depresión en pacientes con enfermedades terminales. Con motivo del Día Internacional de Acción contra la Migraña, Infocop repasa el papel de la Psicología en el abordaje de esta enfermedad neurológica y su relación bidireccional con la salud mental. El BOE publica además la convocatoria PIR 2026-2027, que oferta 293 plazas para la especialidad de Psicología Clínica.

## Noticias nacionales

---

INVESTIGACIÓN · NACIONAL

## La Terapia de Aceptación y Compromiso muestra resultados prometedores en enfermedades terminales

Una revisión sistemática con metaanálisis publicada en la revista *Psicothema* concluye que la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) puede mejorar la calidad de vida y reducir los síntomas de ansiedad y depresión en personas con enfermedades terminales, con beneficios que pueden mantenerse entre uno y nueve meses después del tratamiento. La ACT fomenta la aceptación de experiencias internas difíciles y la actuación conforme a los valores personales, con el objetivo de aumentar la flexibilidad psicológica más que de eliminar síntomas. Los autores del trabajo, Macías, Lara-Merín y López-Pinar, buscaron estudios en PubMed, Scopus y PsycInfo publicados hasta el 26 de mayo de 2025, siguiendo las directrices PRISMA y con registro previo en PROSPERO. El metaanálisis incluyó 13 estudios con 1.109 participantes, con una edad media de 61,5 años y un 55,7% de mujeres; nueve estudios analizaron pacientes con cáncer avanzado y otros incluyeron esclerosis lateral amiotrófica y enfermedades progresivas atendidas en cuidados paliativos. Frente a los grupos de control activos, la ACT produjo mejoras significativas y moderadas en calidad de vida, ansiedad y depresión, con mejores efectos en los tratamientos presenciales frente a los remotos o combinados, aunque esta diferencia requiere prudencia por el tamaño reducido de algunos subgrupos. La flexibilidad psicológica y la acción guiada por valores predijeron las mejoras en calidad de vida, aunque no predijeron de forma consistente la reducción de la ansiedad y la depresión. Los autores señalan limitaciones como el uso exclusivo de medidas de autoinforme, la elevada heterogeneidad entre estudios y la posible existencia de sesgo de publicación, y recomiendan ensayos de mayor calidad que amplíen la investigación a enfermedades no oncológicas, cuidadores y profesionales sanitarios.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España), sobre estudio publicado en *Psicothema*

### SALUD PÚBLICA · NACIONAL

## Sanidad presenta un manual para combatir el estigma en salud mental

El Ministerio de Sanidad y el Comisionado de Salud Mental han presentado la campaña *Acércate, escucha, acompaña, repara*, que incluye un Manual de reparación con herramientas dirigidas a la población general para acompañar a

personas que atraviesan problemas de salud mental. El documento no se presenta como un conjunto de técnicas profesionales, sino como recursos cotidianos basados en escuchar, acercarse, sostener y acompañar, y pone el foco en el estigma como uno de los factores sociales que pueden generar aislamiento, soledad y ruptura de vínculos familiares, laborales y sociales. El manual organiza sus recomendaciones en torno a diez acciones: acercarse, escuchar, acompañar, comprender, nombrar sin miedo, respetar, sostener, incluir, tener paciencia y cuidar los vínculos, cada una ilustrada con situaciones cotidianas. Entre las recomendaciones se incluye escuchar sin juzgar ni interrumpir, mantener el contacto cuando existe aislamiento y evitar burlas, juicios o actitudes condescendientes. Una de las herramientas, 'nombrar sin miedo', aconseja hablar con naturalidad sobre lo que provoca sufrimiento; el manual señala expresamente que hablar sobre el hecho de pensar en morir no provoca que la persona pase al acto. El documento también desarrolla el concepto de 'discapacidad psicosocial' para referirse a las limitaciones que pueden experimentar personas con depresión, ansiedad o psicosis cuando su condición interactúa con barreras sociales, institucionales o ambientales, y destaca que estas limitaciones pueden mejorar mediante apoyos adecuados, tratamiento y entornos inclusivos. El manual puede consultarse en la web del Ministerio de Sanidad.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España), sobre campaña del Ministerio de Sanidad

#### CLÍNICA · NACIONAL

### **Día Internacional de Acción contra la Migraña: el papel de la Psicología en su abordaje integral**

Cada 12 de septiembre se conmemora el Día Internacional de Acción contra la Migraña. En 2026, la Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE) pone el foco en el lema #LasPalabrasImportan, sobre el papel del lenguaje en la percepción social de esta enfermedad neurológica, que según la OMS afectó en 2021 a aproximadamente el 40% de la población mundial y en España afecta a más de 6 millones de personas, alrededor del 13% de la población. Según la Guía de estilo de migraña, elaborada por el Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y avalada por AEMICE, se recomienda hablar de 'migraña' en singular y de 'ataque de migraña', y usar un lenguaje

centrado en la persona, evitando etiquetas como 'migrañoso'. La evidencia disponible indica que la relación entre migraña y salud mental es bidireccional: según la American Migraine Foundation, los problemas de salud mental afectan aproximadamente al 54% de las personas con más de 15 días de migraña al mes, frente al 34% entre quienes tienen menos de 15. La intervención psicológica no implica considerar que la migraña tenga un origen psicológico, sino abordar los procesos emocionales, cognitivos y conductuales que pueden modular la experiencia del dolor y la adaptación a la enfermedad. Entre las intervenciones psicológicas más estudiadas se encuentran la terapia cognitivo-conductual, las técnicas de relajación y el biofeedback; en niños y adolescentes, la evidencia recogida por Yum y Chu (2025) indica que la TCC puede reducir tanto la frecuencia de las cefaleas como los síntomas depresivos y ansiosos, especialmente cuando se combina con psicoeducación sobre desencadenantes y manejo del estrés.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España)

## Publicaciones científicas recientes

Zhao, H., & Huang, H. (2026). Follow-up effects of mindfulness-based interventions on anxiety in adolescents: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*.

DOI: [10.1186/s13034-026-01134-0](https://doi.org/10.1186/s13034-026-01134-0)

**Hallazgo:** Los autores realizaron una revisión sistemática y metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados que evaluaban intervenciones basadas en mindfulness (MBI) en adolescentes de 10 a 19 años, centrado específicamente en los efectos de seguimiento sobre la ansiedad a partir de los 3 meses tras el tratamiento. El protocolo siguió las directrices PRISMA 2020 y fue registrado previamente en PROSPERO. Se buscó en PubMed, Embase, Web of Science, Cochrane Library, Scopus y CNKI desde el inicio de cada base hasta noviembre de 2025, con evaluación del riesgo de sesgo mediante la herramienta Cochrane RoB 2 y análisis de subgrupos por edad, tipo de intervención e intervalo de seguimiento. Se incluyeron 11 ensayos con un total de 9.856 adolescentes. En conjunto, las MBI se asociaron con una reducción modesta de los síntomas de ansiedad en el seguimiento a partir de los 3 meses

(diferencia de medias estandarizada de  $-0,30$ ). El análisis por subgrupos mostró un efecto moderado entre los 3 y los 6 meses ( $-0,40$ ), pero un efecto muy pequeño a partir de los 6 meses ( $-0,09$ ), con una diferencia significativa entre ambos subgrupos.

**Implicación clínica:** Los resultados sugieren que las intervenciones basadas en mindfulness pueden aportar un beneficio modesto de seguimiento sobre la ansiedad adolescente, impulsado principalmente por las mediciones realizadas entre los 3 y los 6 meses. Los propios autores señalan que la evidencia a partir de los 6 meses es limitada y de certeza baja, por lo que no respalda una conclusión firme sobre el mantenimiento de los efectos a más largo plazo. Puede ser relevante valorar, en la práctica clínica y escolar, la incorporación de componentes orientados al mantenimiento del efecto, como sesiones de refuerzo o apoyo continuado a la práctica, ya que según los autores podrían mejorar la durabilidad de los beneficios observados.

## Herramientas clínicas e instrumentos

– **Manual de reparación: acércate, escucha, acompaña, repara:** Guía del Ministerio de Sanidad y el Comisionado de Salud Mental, dirigida a la población general, con diez herramientas cotidianas para acompañar a personas con problemas de salud mental y combatir el estigma y el aislamiento asociados.

## Prioridades del día

### Revisar el lenguaje utilizado al hablar de migraña con pacientes

Puede ser útil explorar, en la práctica clínica con personas que conviven con migraña, el uso de un lenguaje centrado en la persona y libre de banalización, en línea con las recomendaciones de la Guía de estilo de migraña de la SEN.

**Incorporar recursos de acompañamiento del entorno en casos de sufrimiento intenso**

Puede ser relevante compartir con familiares y allegados de pacientes recursos como el Manual de reparación del Ministerio de Sanidad, como complemento no clínico al trabajo terapéutico individual.

### **Valorar el papel de la ACT en el acompañamiento de procesos de final de vida**

Puede ser oportuno revisar la evidencia disponible sobre la Terapia de Aceptación y Compromiso al plantear intervenciones con pacientes con enfermedades avanzadas o progresivas, sin perder de vista que los resultados no respaldan un protocolo idéntico para todos los casos.